5C

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Adalys Anastasia Mancilla Arevalo		Sexo	F X	M
Fecha Nacimiento	17/01/2015	Edad actual	11 años 01 meses	País natal:	chile
Domicilio actual:	Paso Pilnaudi C. 2126 Lines de Acony		Teléfono	98002877 (papá)	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☒ escribe ☒		
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☒ escribe ☒		
Escolaridad actual:	5º bás	Establecimiento	Básico 1		

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 12/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Vania Arevalo	Nombre:
Relación con el/la estudiante: mamá.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 12/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Ericka Calderóns	Nombre:
Rol/cargo: Psicopedagoga.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Dificultades de aprendizaje, se distrae frecuentemente y no siempre finaliza actividades.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☒ No ☐ Sí **(especificar)**

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☒ cesárea (señalar motivo) Por retraso / inducción.

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO Peso: 3.280 Talla: 49 cm.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

Parto inducido por cumplimiento de semanas.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	[✓ Sí]	No	Traumatismos	Sí	[✓ No]	Encefalitis	Sí	[✓ No]
Obesidad	Sí	[✓ No]	Intoxicación	Sí	[✓ No]	Meningitis	Sí	[✓ No]
Fiebre alta	Sí	[✓ No]	Enfermedad respiratoria	[✓ Sí]	No	Otra(s) —		
Convulsiones	Sí	[✓ No]	Asma	Sí	[✓ No]			
Hospitalizaciones	Sí	[✓ No]	Especifique motivos y duración: Adenoides, operado a los 3 años.					
Se realizaron controles periódicos de salud	[✓ Sí]	No	Vacunas				[✓ Sí]	No

Observaciones:

- Derivada a sala de estimulación hasta los 2ā.
- No subió de peso. A los 4 años se estabilizó en peso.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: —
Se sienta sólo/a:
Camina sin apoyo: 3 años.
Primeras palabras: —
Primeras frases: ✓
Se viste solo/a: sí
Controla esfínter vesical Diurno: ✓ Nocturno: ✓
Controla esfínter anal Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Observaciones:

- Retraso en todos los hitos / hiperlaxitud muscular.
- Control esfínter tardío.

En su actividad motora general se aprecia: ☒ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia: ☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	[✓ Sí]	No	Caídas frecuentes	Sí	[✓ No]	Dominancia lateral	[✓ Sí]	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra								
Ensarta	[✓ Sí]	No	Prensión	[✓ Sí]	No	Pinza	[✓ Sí]	No
	[✓ Sí]	No	Dibuja	[✓ Sí]	No	Escribe	[✓ Sí]	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares					
Demanda objetos y compañía	[✓ Sí]	No	Manipula y Explora objetos	[✓ Sí]	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	[✓ Sí]	No	Comprende prohibiciones	[✓ Sí]	No
	[✓ Sí]	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Sí	[✓ No]

Observaciones:

Sin observaciones.

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	[✓ Sí]	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	[✓ Sí]	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	[✓ No]	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	[✓ Sí]	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	[✓ No]	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	[✓ Sí]	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	[✓ No]	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	[✓ No]
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	[✓ Sí]	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	[✓ No]
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	[✓ No]	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	[✓ No]
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	[✓ No]	La pronunciación oral es adecuada	[✓ Sí]	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	[✓ No]	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	[✓ No]

Observaciones:

Sin observaciones.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☒ oral ☒ gestual ☒ mixto _ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	[✓ Sí]	No	Emite/produce frases	[✓ Sí]	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	[✓ Sí]	No	Relata experiencias	[✓ Sí]	No
Emite palabras/produce señas	[✓ Sí]	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	[✓ Sí]	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones simples	[✓ Sí]	No
Identifica personas	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	[✓ No]
Comprende conceptos abstractos	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones grupales	[✓ Sí]	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	[✓ Sí]	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	[✓ Sí]	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): —

Observaciones:

Sin dificultades en lenguaje/En instrucciones complejos solo realiza algunas.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	[✓ Sí]	No	Se relaciona en forma colaborativa	[✓ Sí]	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	[✓ Sí]	No	Respeta normas sociales	[✓ Sí]	No
Participa en actividades grupales	[✓ Sí]	No	Respeta normas escolares	[✓ Sí]	No
Opta por trabajo individual	Sí	[✓ No]	Muestra sentido del humor	[✓ Sí]	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	[✓ No]	Movimientos estereotipados	Sí	[✓ No]
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	[✓ No]	Pataletas frecuentes	Sí	[✓ No]

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces: ☒ natural ☐ desmesurada	**Sonidos:** ☒ natural ☐ desmesurada	**Personas extrañas:** ☒ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

Sin observaciones.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	☒ Sí	No	Trastorno motor		
Epilepsia	Sí	☒ No	Problema bronco-respiratorio	Sí	☒ No
Problemas cardiacos	Sí	☒ No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	☒ No
Paraplejia	Sí	☒ No	Trastorno emocional	Sí	☒ No
Pérdida auditiva	Sí	☒ No	Trastorno conductual	Sí	☒ No
Pérdida visual	Sí	☒ No	Otro (especifique): ——	Sí	☒ No

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): ——

Alimentación: ☐ normal ☒ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☐ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☒ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 6 horas app

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos

☐ sonambulismo ☒ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☒ acompañado

(Especifique): con hermana en la misma pieza.

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☒ alegre ☐ juguetón/bromista ☒ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro:

Observaciones: Es mañosa y lenta para comer.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Vania Arevalo	mamá	32	4º M.	D. de casa / Indep.
2. José Mancilla	Papá	34	3º M.	Independiente.
3. Agustina Mancilla	hermana	3a	—	—
4. Maximiliano Mancilla	hermano	14a	8º	Estudiante.
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

sin antecedentes relevantes.

Observaciones:

sin observaciones.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	2a	Asistió a jardín infantil				☒ Sí	No
Nº de colegios en que ha estudiado	3	Modalidad de enseñanza Regular ☒ Especial ☐ Técnica ☐:					
Motivo de los cambios: Por cambio de domicilio.							
Ha repetido curso/s	☒ Sí	No	Curso(s) 3°	Motivo: Por dificultad de aprendizaje			

Situación actual

Nivel/curso actual	5° C		**Dificultad de aprendizaje**	☒ Sí	No	**Dificultad para participar**	Sí	☒ No	**Conducta disruptiva**	Sí	☒ No
Asiste regularmente	☒ Sí	No	Asiste con agrado	☒ Sí	No	Apoyo familiar en tareas	☒ Sí	No	Amigos (as)	Sí	☒ No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☐ satisfactorio ☒ insatisfactorio (motivos) ...... Podría mejorar

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra ....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra ....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☒ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s)..........

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☒ madre ☒ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales ....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☒ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☒ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

- apoyo en contenidos específicos hermano mayor.
- Pasa mayor parte del tiempo en su pieza.
- Permanencia hasta 8vo básico.

5